Seguro Integral de Salud

Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones

Compendio de Reglas

Auditoría Automatizada

Directiva 001-2025-SIS/GREP-V.01

12 DE AGOSTO DE 2026

Nota: Las reglas automatizadas, con sus variables, descripciones y acciones finales, están disponibles en el portal institucional del SIS.

Acceder en el siguiente enlace https://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/miradorgrep.html

Zulma Anaya Chacón
Jefe del Seguro Integral de Salud.

Pedro Alejandro Cruzado Puente
Jefe adjunto

Wilder Vidauro Carpio Montenegro
Gerente de Riesgos y Evaluación de Prestaciones

Marith Ubilda Guevara Idrogo
Gerente Adjunta

Equipo técnico GREP

- Albarracín Celis, Roberto Carlos (MC.)
- Aliaga Sihuas, Lizet (CD.)
- Bocanegra Campos, Rosa María (MC.)
- Charca Quispe, Esteban Alberto (CD.)
- Quevedo Mar, Alex Francisco (MC.)
- Quispe Huamán, Patricia Gladys (MC.)
- Sifuentes Mendoza, Raúl Hugo (Ing.)
- Anco Pola, Dulio Manuel (MC.)
- Castro Dañobeytia, Verónica Eveling (Lic. Enf.)
- Cuéllar Durán, Karina (MC.)
- Fernández Salcedo, Creazy María (MC.)
- Figueroa Maturrano, Sherly Katherine (Lic. Enf.)
- Peralta Cárdenas, Miguel Ángel (CD.)

Colaboradores

- Anccori Chalco, Jenny Jessica (Bach. Ing.)
- García Celestino, Jessica Rossana (QF.)
- Javier Bartolo, Cintia Nataly (MC.)
- Ishizaki Galarret, Sofia Soraya (MC.)
- Nazario Arancibia, Juan Carlos (MC.)
- Santos Angulo, Jefferson G. (Ing.)
- Racchumi Nanfuñay Karla Justina (MC.)
- Villazana Flores Joselin Andrea (MC.)

Agradecimiento

De manera especial, se reconoce la **contribución y el valioso aporte técnico de los siguientes médicos auditores en la presente actualización**, cuya participación ha permitido fortalecer y perfeccionar los criterios técnicos incorporados en este documento.:

- Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo (DICOE)- FISSAL
- Alvarado Diaz, Melissa Betzabe (MC.) – UDR La Libertad
- Alarcon Torres, Gerald Alexander (MC) – UDR Tacna

Índice

1 FINALIDAD 7

2 OBJETIVOS 7

2.1 Objetivo General 7

2.2 Objetivo Especifico 7

3 DISPOSICIONES GENERALES 8

3.1 Acrónimos 8

3.2 Definiciones 8

4 REGLAS DE CONTROL DE REGISTRO 9

4.1 RR_00 Identificación y vigencia de cobertura prestacional del asegurado. 9

4.2 RR_02 Restricción del registro de insumos no asociados a la atención individual de salud. 9

4.3 RR_03 Restricción del registro de medicamentos no asociados a la atención individual de salud 10

4.4 RR_05 Parámetros de registro de las actividades preventivas y clínicas 10

4.5 RR_08 Restricción de registro de colegiatura y especialidad por tipo de personal de salud. 11

4.6 RR_10 Codificación de las especialidades y necesidad de contar con RNE 11

4.7 RR_82 Control lotes autorizados por año calendario. 12

5 REGLAS DE CONSISTENCIA 12

5.1 RC_01 Consistencia de registro de prestaciones por edad, sexo y condiciones del asegurado 12

5.2 RC_04 Criterios de registro del destino del asegurado por prestación 13

5.3 RC_06 Límites de registro de medicamentos por unidad de medida 13

5.4 RC_09 Uso de oxígeno y accesorios para bombas de infusión 14

5.5 RC_12 Medicamentos, insumos y/o procedimientos asociados a la prestación ... 14

5.6 RC_13 Consistencia de registro según código prestacional. 15

5.7 RC_14 Obligatoriedad de registro de actividades preventivas y clínicas por código prestacional 15

5.8 RC_17 Control de duplicidad de FUA 16

5.9 RC_20 Consistencia de registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención 16

5.10 RC_26 Control de extemporaneidad en el envió de información de las prestaciones 17

5.11 RC_27 Consistencia y obligación de diagnósticos preventivos por código de prestación 17

5.12 RC_30 Registro obligatorio de fecha probable de parto/fecha de parto en prestaciones obstétricas 18

5.13 RC_31 Registro obligatorio de resultados en procedimientos clínicos 18

5.14 RC_32 Consistencia clínica en procedimientos mutuamente excluyentes 19

5.15 RC_33 Registro obligatorio de datos del recién nacido 19

5.16 RC_34 Registro de diagnóstico obligatorio en tamizaje de salud mental patológico 19

5.17 RC_35 Registro de medicamentos específicos por código prestacional o diagnóstico. 20

5.18 RC_39 Límites de registro por procedimiento, vinculados a códigos prestacionales 20

5.19 RC_40 Regla de auditoría de estancias prolongadas con corte administrativo 21

5.20 RC-42 Registro de atenciones posteriores a la fecha de fallecimiento 21

5.21 RC_46 Procedimientos de aplicación única por atención, según profesional y nivel de atención 22

5.22 RC_47 Consistencia multinivel y multivariables en procedimientos 22

5.23 RC_53 Criterios para Registrar los Diagnósticos CIE-10 según sexo y condición materna 23

5.24 RC_57 Prestaciones con restricción de registro simultáneos 23

5.25 RC_58 Productos de origen biológico y/o de alto costo. 24

5.26 RC_59 Consistencia entre procedimientos y días de estancia hospitalaria 24

5.27 RC_74 Sustitución controlada de dispositivos médicos (marcapasos) por periodicidad 24

5.28 RC_75 Coherencia clínica en el uso de dispositivos para marcapasos 25

5.29 RC_76 Restricción de procedimientos por diagnostico especifico 25

5.30 RC_77 Compatibilidad de códigos prestacionales 26

5.31 RC_79 Consistencia entre código prestacional y profesional responsable 26

5.32 RC_81 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades I 27

5.33 RC_83 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades II. 27

5.34 RC_86 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades III 28

5.35 RC_87 Restricción del registro de prestaciones según tipo de atención 28

5.36 RC_88 Consistencia entre los diagnósticos y procedimientos según curso de vida 29

5.37 RC_89 Registro condicionado de procedimientos a diagnósticos según curso de vida 29

5.38 RC_90 Control de atenciones diarias en consulta externa brindado por personal de salud 30

5.39 RC_91 Consistencia de diagnósticos por código prestacional 30

5.40 RC_92 Consistencia de registro de códigos prestacionales por nivel de atención . 31

5.41 RC_94 Dispositivos médicos asociados a medicamentos 31

5.42 RC_95 Coherencia clínica en el uso de surfactante pulmonar en el recién nacido 32

5.43 RC_96 Consistencia de asociación obligatoria a CPMS base 32

5.44 RC_97 Insumos con pertinencia de uso para los Procedimientos de Alto Costo que cobertura el FISSAL..... 33

5.45 RC_98 Registro obligatorio de diagnósticos en la atención del parto 34

6 REGLAS DE VALIDACIÓN 34

6.1 RV_26 Restricción de medicamentos e insumos evaluados según ETS. 34

6.2 RV_28 Restricción de productos de origen biológico o de alto costo 35

6.3 RV_29 Restricción de registros en exceso de CPMS de tomografía 36

6.4 RV_30 Restricción de registro medicamentos en hospitalización 36

6.5 RV_31 Diagnóstico de sepsis neonatal sustentado en criterios clínicos y de laboratorio. 37

7 ACTUALIZACIONES Y NUEVAS REGLAS 37

7.1 ACTUALIZACION DE REGLAS SEGUN INFORME N.º 000012-2026-SIS/GREP-VCD (03/06/2026) 37

7.1.1. Actualización de la RR_02..... 37

7.1.2. Actualización de la RC_01..... 38

7.1.3. Actualización de la RC_06..... 38

7.1.4. Actualización de la RC_14..... 38

7.1.5. Actualización de la RC_20..... 38

7.1.6. Actualización de la RC_32..... 39

7.1.7. Actualización de la RC_39..... 39

7.1.8. Actualización de la RC_47..... 39

7.1.9. Actualización de la RC_53..... 40

7.1.10. Actualización de la RC_88..... 40

7.1.11. Actualización de la RC_89..... 40

7.1.12. Actualización de la RC_94..... 41

7.1.13. Actualización de la RV_26 41

7.1.14. Actualización de la RV_29 41

7.2 CREACION DE REGLAS SEGÚN INFORME N.º 000012-2026-SIS/GREP-VCD (03/06/2026) 41

7.2.1. Creación de la RC_97 41

7.2.2. Creación de la RC_98 42

1 FINALIDAD

El presente compendio tiene como finalidad fortalecer el sistema de auditoría automatizada del Seguro Integral de Salud (SIS), estableciendo un marco normativo, técnico y operativo que asegure la transparencia, eficiencia y calidad en el registro y validación de las prestaciones de salud financiadas con recursos públicos.

Busca consolidarse como una herramienta de gobernanza digital en salud, orientada a:

- Prevenir inconsistencias, duplicidades y fraudes en los registros prestacionales.
- Optimizar el uso racional de los recursos del Estado destinados al aseguramiento en salud.
- Garantizar que la información registrada en los sistemas del SIS sea confiable, oportuna y útil para la toma de decisiones estratégicas, tanto en la gestión prestacional como en la planificación financiera.
- Contribuir a la mejora continua de la calidad de la atención en las IPRESS financiadas por el SIS, alineándose con los principios de universalidad, equidad y eficiencia del sistema de salud peruano

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Consolidar un **sistema integral de reglas de auditoría automatizada** que permita asegurar la calidad, coherencia y validez de la información prestacional registrada por las IPRESS, fortaleciendo los procesos de control, supervisión y financiamiento del SIS

2.2 Objetivo Especifico

- Estandarizar los criterios técnicos y operativos que orientan la auditoría automatizada, en concordancia con la normativa nacional e internacional en materia de aseguramiento y auditoría de prestaciones de salud
- Definir y aplicar reglas de control, consistencia y validación que funcionen como **filtros automáticos** para asegurar registros íntegros, confiables y libres de inconsistencias.
- Prevenir la ocurrencia de fraudes, sobrerregistros o uso indebido de los recursos financieros del SIS.
- Reducir el riesgo financiero y operativo asociado al pago de prestaciones improcedentes.

3 DISPOSICIONES GENERALES

3.1 Acrónimos

- FUA: Formato Único de Atención
- IPRESS: Institución Prestadora de Servicios de Salud
- SIS: Seguro Integral de Salud
- RR: Regla de Control de Registro
- RC: Regla Consistencia
- RV: Regla Validación

3.2 Definiciones

- **Formato Único de Atención (FUA)**

  Es el instrumento en el que se registran y acreditan, en físico o en medio magnético, los datos requeridos por el SIS sobre las prestaciones asistenciales y/o administrativas, como los del asegurado que la recibe. Se caracteriza por contener una numeración única que lo identifica y se utiliza como fuente de información para los registros informáticos del SIS, así como para los procesos de auditoría o de validación prestacional. El FUA (físico o electrónico) tiene carácter de declaración jurada

- **Reglas de Control de Registro (RR)**

  Son parámetros mínimos de registro que actúan como un filtro de control para permitir el ingreso de las prestaciones de salud en los aplicativos informáticos del SIS. Sus resultados no implican la superación de Reglas de Consistencia.

- **Reglas de Consistencia (RC)**

  Criterios de registro de las prestaciones de salud que actúan como filtros de control para permitir el ingreso de datos en los aplicativos informáticos del SIS. Estas reglas son de dos tipos: inmediata y mediata.

  a. Reglas de consistencia inmediata: son las reglas que actúan durante el registro de la prestación en los aplicativos informáticos el SIS, y de no ser superadas no permiten grabar la prestación.
  b. Reglas de consistencia mediatas: son las reglas que se aplican de forma posterior a la digitación.

- **Reglas de Validación (RV)**

  Son criterios técnicos que verifican el cumplimiento del adecuado registro, estándares de calidad de atención, oportunidad e integralidad de acuerdo con la normatividad vigente que deben cumplir las prestaciones financiadas por el SIS. De no ser superadas, generan observaciones en el registro (parcial o total del FUA), pero no impiden guardar ni enviar la información de la prestación, pudiendo ser levantadas posteriormente durante los procesos de auditoría correspondiente.

4 REGLAS DE CONTROL DE REGISTRO

4.1 RR_00 Identificación y vigencia de cobertura prestacional del asegurado.

- Denominación
  Identificación y vigencia de cobertura prestacional del asegurado.
- Objetivo
  Garantizar que solo se registren las prestaciones de salud de asegurados con cobertura prestacional vigente.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  La regla verifica la existencia del identificador único, que la fecha de atención se encuentre dentro del periodo de cobertura vigente y que los datos personales correspondan de manera consistente.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Un asegurado con fecha de afiliación 01/03/2025 y sin fecha de baja recibe atención el 15/05/2025. El sistema valida que el N° de afiliación existe, la cobertura es vigente y los datos coinciden. → Registro exitoso.
  - No válido: El FUA se genera para un asegurado cuya cobertura terminó el 30/04/2025, pero la atención se realizó el 15/05/2025. → No permite el registro.

4.2 RR_02 Restricción del registro de insumos no asociados a la atención individual de salud.

- Denominación
  Restricción del registro de insumos no asociados a la atención individual de salud
- Objetivo
  Restringir la visualización de insumos que no guardan relación con la prestación, ya sea porque no corresponden a los utilizados en una atención individual de salud o porque forman parte de la estructura cuali-cuantitativa aprobada por el SIS, a fin de garantizar la pertinencia y precisión del registro.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  La regla restringe el registro de insumos que estén vinculados a la atención individual registrada en el FUA, según el listado determinado por el SIS.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: En una prestación se prescribe un insumo no restringido por el SIS para esa prestación. → Registro exitoso.
  - No válido – Insumo no incluido en catálogo: Se prescribe un insumo restringido por el SIS para esa prestación. → No permite el registro.

4.3 RR_03 Restricción del registro de medicamentos no asociados a la atención individual de salud

- Denominación
  Restricción del registro de medicamentos no asociados a la atención individual de salud
- Objetivo
  Restringir la visualización de medicamentos que no guardan relación con la prestación, ya sea porque no corresponden a los utilizados en una atención individual de salud o porque forman parte de la estructura cuali cuantitativa aprobada por el SIS, a fin de garantizar la pertinencia y precisión del registro
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  La regla restringe el registro de medicamentos que estén vinculados a la atención individual registrada en el FUA, según el listado determinado por el SIS.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: En una prestación se prescribe un medicamento no restringido por el SIS para esa prestación. → Registro exitoso.
  - No válido – medicamento no incluido en catálogo: Se prescribe un medicamento restringido por el SIS para esa prestación. → No permite el registro.

4.4 RR_05 Parámetros de registro de las actividades preventivas y clínicas

- Denominación
  Parámetros de registro de las actividades preventivas y clínicas.
- Objetivo
  Habilitar el registro de actividades preventivas y clínicas en prestaciones específicas, optimizando la calidad del registro durante la digitación y fortaleciendo la consistencia de la información generada
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  Habilitación de la información conforme a los parámetros preestablecidos, verificando su cumplimiento antes de permitir el registro.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro de IMC = 23.5 kg/m² (dentro del rango 10.00 – 56.00). → Registro exitoso
  - No válido: Registro de edad gestacional = 50 semanas (fuera del rango 1–42) → No permite el registro.

4.5 RR_08 Restricción de registro de colegiatura y especialidad por tipo de personal de salud.

- Denominación
  Restricción de registro de colegiatura y especialidad por tipo de personal de salud.
- Objetivo
  Restringir y habilitar según corresponda los campos de colegiatura y/o especialidad, para la atención de las prestaciones de salud.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  Verifica, de acuerdo con el tipo de responsable de atención seleccionado, la obligatoriedad del registro del número de colegiatura y la consignación de la especialidad.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Tipo 3 (Odontólogo) con colegiatura registrada y especialidad en blanco (opcional) → Registro exitoso.
  - No válido: Tipo 2 (Farmacéutico) sin colegiatura → No permite el registro.

4.6 RR_10 Codificación de las especialidades y necesidad de contar con RNE

- Denominación
  Codificación de las especialidades y necesidad de contar con RNE
- Objetivo
  Obligar el Registro Nacional de Especialista (RNE) cuando corresponda.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  Cuando el responsable de atención seleccione una especialidad que, de acuerdo con la normativa vigente, requiera Registro Nacional de Especialista (RNE), el aplicativo debe exigir de manera obligatoria el ingreso del número de RNE.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Médico con especialidad 'Cardiología' sin consignar RNE → No permite el registro.
  - Válido: Odontólogo con especialidad 'Ortodoncia y Ortopedia Maxilar' con RNE consignado → Registro exitoso.

4.7 RR_82 Control lotes autorizados por año calendario.

- Denominación
  Control lotes autorizados por año calendario.
- Objetivo
  Garantizar la coherencia entre el lote de FUA y el año calendario correspondiente, restringiendo el registro de prestaciones fuera del período autorizado.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  El aplicativo debe verificar que el año consignado en el número de lote del Formato Único de Atención (FUA) corresponda al año calendario vigente. Si el año del lote no coincide con el periodo autorizado, se restringe el registro de la prestación hasta que la información sea corregida.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Lote 25 Atención registrada el 15/08/2025 con FUA lote 25 → Registro exitoso.
  - No válido: Lote 24 fuera de rango: Atención el 20/07/2025 con FUA lote 24 → No permite el registro.

5 REGLAS DE CONSISTENCIA

5.1 RC_01 Consistencia de registro de prestaciones por edad, sexo y condiciones del asegurado

- Denominación:
  Consistencia de registro de prestaciones por edad, sexo y condiciones del asegurado.
- Objetivo
  Optimizar la calidad de la información asegurando que las prestaciones se registren únicamente cuando corresponda a la edad, sexo y condición de salud.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas, recuperativas, de rehabilitación y administrativas.
- Definición Operacional
  Para cada código prestacional se establecen los rangos de edad, el sexo, la condición de hospitalización y los campos correspondientes (gestante, puérpera o no gestante/puérpera).
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Atención de parto vaginal (054) con sexo femenino → Registro exitoso.
  - No válido: Control de crecimiento y desarrollo (001) con hospitalización → No permite el registro.

5.2 RC_04 Criterios de registro del destino del asegurado por prestación

- Denominación:
  Criterios de registro del destino del asegurado por prestación.
- Objetivo
  Habilitar únicamente los campos válidos para el destino del asegurado de acuerdo con la prestación, restringiendo aquellos que no sean aplicables al registro.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas, recuperativas, de rehabilitación y administrativas.
- Definición Operacional
  Para cada código prestacional se parametrizan los destinos permitidos, el aplicativo habilito solo los destinos válidos y oculta/bloquea los no aplicables.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Profilaxis antiparasitaria (008) con destino “Emergencia” → No permite el registro.
  - Válido: Atención preventiva (001) con “Citado” → Registro exitoso.

5.3 RC_06 Límites de registro de medicamentos por unidad de medida

- Denominación
  Límites de registro de medicamentos por unidad de medida.
- Objetivo
  Establecer el límite de registro de medicamentos por unidad de medida considerando hospitalizados, no hospitalizados según nivel de atención.
- Alcance
  Establecer topes de registro de medicamentos considerando condición (hospitalizado/no hospitalizado) y nivel de atención (I, II, III) para reducir riesgos financieros.
- Definición Operacional
  Para cada forma terapéutica se parametrizan topes mínimos y máximos diferenciados por condición y nivel de la IPRESS. El aplicativo informático bloquea registros que excedan el tope máximo aplicable al contexto.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Barra (BARRA) en no hospitalizado, nivel II, 2 unidades → Registro exitoso.
  - No válido: Crema para aplicación tópica (CRM) en hospitalizado, nivel II, 120 unidades → No permite el registro.

5.4 RC_09 Uso de oxígeno y accesorios para bombas de infusión

- Denominación
  Prestaciones en las que se puede brindar oxígeno y usar accesorios para bombas de infusión.
- Objetivo
  Establecer límites de registro de oxígeno y de accesorios de bomba de infusión, reduciendo riesgos financieros por sobrerregistros.
- Alcance
  Aplica a las prestaciones asistenciales en las que se consigna consumo de oxígeno y/o uso de accesorios de bombas de infusión en los aplicativos informáticos del SIS.
- Definición Operacional
  Controla los topes mínimos y máximos de consumo diario y total de oxígeno, así como los límites de accesorios de bomba de infusión, según el tipo de prestación registrada. Si se excede un tope máximo o se consigna un valor fuera de los parámetros establecidos, el aplicativo restringe el guardado del registro hasta que la información sea corregida.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Prestación 050 con consumo diario 2500 L y total 0 accesorios (dentro de tope) → Registro exitoso.
  - No válido: Prestación 062 con consumo diario 45000 L (excede tope de 43200) → No permite el registro.

5.5 RC_12 Medicamentos, insumos y/o procedimientos asociados a la prestación

- Denominación
  Registro obligatorio de medicamentos, insumos y/o procedimientos asociados a la prestación
- Objetivo
  Condicionar el registro de las prestaciones a la inclusión obligatoria de medicamentos, insumos y/o procedimientos.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  Según el código de prestación, se requiere el registro de consumo de medicamentos, insumos y/o procedimientos para permitir grabar el FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Registro del código 013 (examen de ecografía obstétrica) sin consignar el procedimiento correspondiente (ecografía) → No permite el registro.
  - Válido: Registro del código 021 (prevención de caries) con el procedimiento debidamente registrado (aplicación de flúor) → Registro exitoso.

5.6 RC_13 Consistencia de registro según código prestacional.

- Denominación
  Consistencia de registro de parto vaginal y cesárea por intervalos de tiempo.
- Objetivo
  Evitar el registro duplicado o indebido de atención de parto vaginal o cesárea en un mismo asegurado dentro de un periodo no permitido, garantizando coherencia clínica y calidad de registro.
- Alcance
  Aplica al registro de FUAs de las prestaciones 054 (Atención de parto) y 055 (Cesárea).
- Definición Operacional
  Controla que en un mismo asegurado no se registren múltiples atenciones de parto vaginal o cesárea dentro de un periodo restringido. Si se detecta un registro duplicado o indebido, se bloquea el guardado de la prestación hasta que la información sea corregida, garantizando la coherencia clínica y la calidad del registro.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Asegurada con parto (054) el 10/03/2025 e intento de registrar otro parto (054) el 20/03/2025 en la misma IPRESS → No permite el registro.
  - Válido: Asegurada con cesárea (055) el 01/01/2025 y nueva cesárea el 15/04/2027 → Registro exitoso.

5.7 RC_14 Obligatoriedad de registro de actividades preventivas y clínicas por código prestacional

- Denominación
  Obligatoriedad de registro de actividades preventivas y clínicas por código prestacional
- Objetivo
  Garantizar que las prestaciones de salud definidas registren las actividades preventivas y clínicas establecidas por la normativa vigente, asegurando la calidad de la información.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas y recuperativas.
- Definición Operacional
  Exige que, en las prestaciones de salud definidas, se registren de manera obligatoria las actividades preventivas y clínicas establecidas en la normativa vigente. En caso de omisión o inconsistencia en dichas actividades, no se permite guardar la prestación hasta que se complete el registro correspondiente, garantizando así la calidad y coherencia de la información.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: 050 sin APGAR → No permite el registro.
  - Válido: 054 con registro de peso, talla, edad gestacional y presión arterial→ Registro exitoso.

5.8 RC_17 Control de duplicidad de FUA

- Denominación
  Control de duplicidad de FUA
- Objetivo
  Evitar la duplicidad en el registro de prestaciones, garantizando la identificación única de cada atención.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  Se considera FUA duplicado cuando en los aplicativos informáticos del SIS existen dos registros con la misma combinación de identificadores: código RENIPRESS, Periodo de producción y correlativo.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: FUA 036-25-12345678 registrado como único en el sistema → Registro exitoso.
  - No válido: Se repite el FUA 036-25-87654321 dos veces → No permite el registro.

5.9 RC_20 Consistencia de registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención

- Denominación
  Consistencia de registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención.
- Objetivo
  Limita el registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención, asegurando la consistencia de registro.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  Cada procedimiento CPMS debe registrarse únicamente cuando el profesional que lo ejecuta corresponde al perfil habilitado, considerando además las condiciones de nivel de atención y código prestacional establecidas. En caso de no cumplirse estos criterios, el aplicativo no permitirá completar el registro.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: CPMS 59514 (Cesárea solamente) registrado por psicólogo (cód. 8) → No permite el registro.
  - Válido: CPMS D5110 (Prótesis dental completa maxilar) registrado por Cirujano Dentista (cód. 3) → Registro exitoso.

5.10 RC_26 Control de extemporaneidad en el envió de información de las prestaciones

- Denominación
  Control de extemporaneidad en el envió de información de las prestaciones.
- Objetivo
  Restringir el registro de las prestaciones fuera de plazo, asegurando la oportunidad del envío y fortaleciendo el control prestacional.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional
  Se calcula el plazo de envío de la información de los FUAs en días calendario según nivel del establecimiento, a partir de la Fecha de atención y las fechas de recepción, retroalimentación (mundo IPRESS) y corrección (actualización), conforme a precisiones operativas.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: (Nivel III): Atención 01/03 (a); recepción 20/03 (b); sin observación → 19 días ≤ 30 → Registro exitoso.
  - No válido: (Nivel III): Atención 01/04 (a); recepción 24/04 (b); Con observaciones, retroalimentación 25/04 (c); corrección 05/05 (d) → (b−a) =23 + (d−c) =10 → 33 días ≤ 30 → No permite el registro.

5.11 RC_27 Consistencia y obligación de diagnósticos preventivos por código de prestación

- Denominación
  Consistencia y obligación de diagnósticos preventivos por código de prestación.
- Objetivo
  Asegurar que las prestaciones preventivas se registren con diagnósticos consistente y no contradictorios, exigiendo la inclusión obligatoria de códigos CIE 10 a fin de garantizar coherencia en la atención integral de salud.
- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas indicadas en la ficha técnica.
- Definición Operacional
  Toda prestación preventiva debe registrarse con al menos un código CIE-10 coherente con la actividad realizada, evitando la consignación de diagnósticos contradictorios. El aplicativo exigirá la inclusión obligatoria de códigos CIE-10 válidos para completar el registro y solo permitirá su cierre cuando la información cumpla con los criterios de consistencia establecidos.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Prestación 001 con Z001 (Control de salud de rutina del niño) registrado → Registro exitoso.
  - No válido: Prestación 022 sin el registro del CEI 10 Z133 (Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento) → No permite el registro.

5.12 RC_30 Registro obligatorio de fecha probable de parto/fecha de parto en prestaciones obstétricas

- Denominación
  Registro obligatorio de fecha probable de parto/fecha de parto en prestaciones obstétricas.
- Objetivo
  Garantiza el registro obligatorio, completo y consistente de la fecha probable de parto y la fecha de parto en todas las prestaciones obstétricas brindadas en los niveles I, II y III asegurando la coherencia temporal entre FPP, FP, Fecha de atención y fecha de alta.
- Alcance
  La presente regla es aplicable a todas las prestaciones de carácter preventivo, recuperativo, de rehabilitación y administrativo relacionadas con la atención de gestantes y puérperas.
- Definición Operacional
  Establece la obligatoriedad de consignar, según corresponda, la fecha probable de parto y la fecha de parto vinculadas al código prestacional registrado. Asimismo, regula la consistencia entre las fechas consignadas, de manera que guarden coherencia temporal con la atención registrada.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: 009 (gestante) sin FPP → No permite el registro.
  - Válido: 055 con FP < ó = Fecha de Alta → Registro exitoso.

5.13 RC_31 Registro obligatorio de resultados en procedimientos clínicos

- Denominación
  Registro obligatorio de resultados en procedimientos clínicos.
- Objetivo
  Asegurar la consistencia y la obligatoriedad del registro de resultados en procedimientos diagnósticos seleccionados.
- Alcance
  Aplicable a todas las prestaciones preventivas y recuperativas que contemplen la determinación de hemoglobina y/o la evaluación de agudeza visual.
- Definición Operacional
  En toda atención que involucre la determinación de hemoglobina o la prueba de agudeza visual, el registro del resultado es obligatorio según el código prestacional. El valor registrado deberá encontrarse dentro de los rangos establecidos.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: CPMS 85018 con resultado 13.5 gr/dL → dentro de rango → Registro exitoso.
  - No válido: CPMS 85027 con resultado 0.8 gr/dL → fuera de rango → No permite el registro.

5.14 RC_32 Consistencia clínica en procedimientos mutuamente excluyentes

- Denominación
  Consistencia clínica en procedimientos mutuamente excluyentes.
  Objetivo
  Garantizar la consistencia clínica evitando la duplicidad de códigos de procedimientos dentro de un mismo grupo relacionado.
- Alcance
  Aplicable a todas las prestaciones preventivas y recuperativas.
- Definición Operacional
  Dentro de un mismo FUA, ciertos procedimientos, insumos o medicamentos pertenecientes al mismo grupo son excluyentes entre sí. Por lo tanto, no se permite el registro simultáneo de los equivalentes o alternativas que representen la misma intervención terapéutica o diagnóstica.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Registrar 59409 y 59410 en el mismo FUA → No permite el registro.
  - Válido: Registrar 55812 sin otro código mutualmente excluyente el mismo FUA → Registro exitoso.

5.15 RC_33 Registro obligatorio de datos del recién nacido

- Denominación
  Registro obligatorio de datos del recién nacido.
- Objetivo
  Obligar el registro de DNI, CNV o código de afiliación en la prestación de parto, asegurando la integración al circuito de identidad.
- Alcance
  Aplica a prestaciones de parto registradas.
- Definición Operacional

  En los FUAs correspondientes a atenciones de parto, es obligatorio registrar al menos uno de los identificadores del recién nacido: Documento Nacional de Identidad (DNI), Código del Certificado de Nacido Vivo (CNV) o número de afiliación.

- Ejemplos Prácticos
  - No válido: FUA con cód. 054 sin DNI/CNV/Afiliación del RN y sin diagnósticos O36.4/P95.X → No permite el registro.
  - Válido: FUA con cód. 055 y diagnóstico P95.X sin DNI/CNV/Afiliación del RN → Registro exitoso.

5.16 RC_34 Registro de diagnóstico obligatorio en tamizaje de salud mental patológico

- Denominación
  Registro de diagnóstico obligatorio en tamizaje de salud mental patológico.
- Objetivo

Obligar el registro de diagnósticos en el tamizaje de salud mental patológico.

- Alcance
  Aplica a prestaciones preventivas listadas (001, 002, 118, 119, 017, 009, 022, 902, 903, 904, 010, 301, 302, 303, 304, 305 y 306) cuando el campo "Tamizaje de Salud Mental Patológico" esté marcado.
- Definición Operacional
  Cuando el campo "Tamizaje de Salud Mental" se registre como patológico, será obligatorio consignar al menos un diagnóstico de la lista permitida. En caso de registrarse como normal, no será necesario asociar diagnósticos.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Prestación 022 con Tamizaje Patológico sin diagnóstico asociado → No permite el registro.
  - Válido: Prestación 017 con Tamizaje Patológico y F32.0 registrado → Registro exitoso.

5.17 RC_35 Registro de medicamentos específicos por código prestacional o diagnóstico.

- Denominación
  Registro de medicamentos específicos por código prestacional o diagnóstico.
- Objetivo
  Obliga el registro de medicamentos para prestaciones preventivas.
- Alcance
  Aplicable a todas las prestaciones preventivas y recuperativas.
- Definición Operacional
  Determinadas prestaciones requieren el registro obligatorio de uno o más medicamentos específicos en el FUA, en concordancia con las características del código prestacional o diagnostico al que se encuentran vinculadas.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: (007) se registra código 20575 → Registro exitoso.
  - No válido: (008) se registran Albendazol (00259) y Mebendazol (04573) simultáneamente → No permite el registro.

5.18 RC_39 Límites de registro por procedimiento, vinculados a códigos prestacionales

- Denominación
  Límites de registro por procedimiento, vinculados a códigos prestacionales
- Objetivo
  Verificar que cada procedimiento (CPMS) se registre en el código prestacional correspondiente, distinguiendo entre registros exclusivos y no exclusivos, y establecer los limites mínimos y máximos permitidos por procedimiento, con el fin de asegurar la pertinencia, consistencia y calidad de la información registrada.
- Alcance
  Aplicable a todas las prestaciones preventivas y recuperativas.

- Definición Operacional
  Para cada CPMS se establecen topes de registro en los ítems de IND/EJE, con valores mínimos y máximos permitidos por FUA, así como los códigos prestacionales principales autorizados. En los casos en que un CPMS se encuentra clasificado como exclusivo, su registro será admitido únicamente cuando se asocie a los códigos prestacionales principales definidos y siempre que se mantenga dentro de los límites establecidos.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: CPMS 59514 (Cesárea) en FUA con código 054 (Parto Vaginal) → No permite el registro.
  - Válido: CPMS 99231 (Días hospitalización) con IND=2, EJE=2 en código 065 → Registro exitoso.

5.19 RC_40 Regla de auditoría de estancias prolongadas con corte administrativo

- Denominación
  Regla de auditoría de estancias prolongadas con corte administrativo.
- Objetivo
  Establecer el periodo de cierre de la prestación en casos de pacientes con estancia prolongada.
- Alcance
  Aplica a códigos prestacionales 051, 052, 065, 067, 068 en atenciones con destino "Corte Administrativo".
- Definición Operacional
  Cuando un paciente permanece hospitalizado por un periodo prolongado, la prestación deberá registrarse con destino “Corte Administrativo”, estableciendo como fecha de cierre aquella que corresponda al periodo de estancia autorizado.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Destino = Corte Administrativo y Fecha de Corte vacía → No permite el registro.
  - Válido: Destino = Corte Administrativo + Fecha de Corte registrada; FUA vinculado del mismo asegurado con corte a 185 días → Registro exitoso.

5.20 RC-42 Registro de atenciones posteriores a la fecha de fallecimiento

- Denominación
  Registro de atenciones posteriores a la fecha de fallecimiento
- Objetivo
  Evita el registro de prestaciones posteriores al registro de la fecha de fallecimiento del asegurado.
- Alcance
  Aplica a todos los códigos prestacionales.
- Definición Operacional

Se valida que la Fecha de Atención (ambulatoria) o la Fecha de Alta (hospitalización) sea anterior o igual a la fecha de fallecimiento del asegurado.

- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Alta hospitalaria el 15/05 con fallecimiento el 15/05 → Registro exitoso.
  - No válido: Alta hospitalaria el 01/08 cuando existe prestación del 28/07 con destino = Fallecido → No permite el registro.

5.21 RC_46 Procedimientos de aplicación única por atención, según profesional y nivel de atención

- Denominación
  Procedimientos de aplicación única por atención, según profesional y nivel de atención.
- Objetivo
  Establecer que los procedimientos definidos como de aplicación única se registren una sola vez por atención, controlados según profesional y nivel de atención.
- Alcance
  Aplica en prestaciones preventivas y recuperativas (906, 903, 904 y 902).
- Definición Operacional
  Los procedimientos clasificados como de aplicación única deberán registrarse exclusivamente una vez por atención, verificando que el registro se efectúe únicamente por el profesional autorizado y dentro del nivel de atención correspondiente. En caso se intente consignar más de un registro para el mismo procedimiento en la misma atención, el aplicativo bloqueará la duplicidad y solo permitirá guardar un registro válido.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: 906 + 90806 (Psicoterapia individual) por psicología Ind 1, Eje 1 → Registro exitoso.
  - No válido: 906 + 99209.02 (Control y evaluación nutricional (IMC)) por psicología en el I nivel de atención Ind 2, Eje 2 → No permite el registro.

5.22 RC_47 Consistencia multinivel y multivariables en procedimientos

- Denominación
  Consistencia multinivel y multivariables en procedimientos.
- Objetivo
  Restringir el registro de procedimientos según profesional, especialidad, edad, condición, género, código prestacional y nivel/categoría de la IPRESS.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones preventivas y recuperativas.
- Definición Operacional
  Un procedimiento (CPMS) debe ser registrado únicamente por el profesional autorizado para su ejecución y en correspondencia con la pertinencia clínica definida según el sexo, la edad y las condiciones específicas del paciente.

- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro de Papanicolaou en paciente femenino → Registro exitoso.
  - No válido: Registro de cesárea en paciente masculino → No permite el registro.

5.23 RC_53 Criterios para Registrar los Diagnósticos CIE-10 según sexo y condición materna

- Denominación
  Criterios para Registrar los Diagnósticos CIE-10 según sexo y condición materna
- Objetivo
  Asegurar el registro coherente y consistente de los diagnósticos CIE-10, considerando la edad, el sexo y la condición materna.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  El diagnóstico CIE-10 debe ser coherente con el sexo del paciente (H/M/A) y, cuando corresponda, con la condición materna, considerando los casos de gestación y/o puerperio.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: C61X (Tumor maligno de la próstata) registrado en paciente femenino → No permite el registro
  - Válido: N411 (Prostatitis crónica) en paciente masculino →Registro exitoso

5.24 RC_57 Prestaciones con restricción de registro simultáneos

- Denominación
  Prestaciones con restricción de registro simultáneos.
- Objetivo
  Garantizar que las prestaciones con restricciones no sean registradas de manera simultánea, evitando duplicidades o inconsistencias en la información.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones preventivas y recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  El aplicativo restringe el registro en el FUA cuando se detectan combinaciones incompatibles entre códigos prestacionales, duplicidades dentro de ventanas temporales o coincidencias en la misma fecha o durante una misma estancia hospitalaria.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: 065 sin otros códigos registrados en la estancia hospitalaria → Registro exitoso.
  - No válido: 054 coexistente con 055 en 4 meses → No permite el registro.

5.25 RC_58 Productos de origen biológico y/o de alto costo.

- Denominación
  Productos de origen biológico y/o de alto costo priorizados evaluados y no evaluados por ETS o con autorización restringida por PNUME.
- Objetivo
  Restringir el registro de medicamentos de origen bilógico o de alto costo.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  Cuando el medicamento corresponda a los listados de biológicos o de alto costo, el aplicativo exigirá: que la prestación sea registrada únicamente en IPRESS de nivel II o III, la generación automática de un aviso operativo según el caso, y el cumplimiento de restricciones adicionales, como la obligatoriedad de consignar códigos CIE-10 específicos para determinados fármacos.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: IMATINIB (04043) con CIE-10 D460 en IPRESS nivel II y III→ Registro exitoso.
  - No válido: IMATINIB (04043) con CIE-10 no permitido→ No permite el registro.

5.26 RC_59 Consistencia entre procedimientos y días de estancia hospitalaria

- Denominación
  Consistencia entre procedimientos y días de estancia hospitalaria.
- Objetivo
  Restringe el tope de procedimientos en relación a los días de estancia hospitalaria.
- Alcance
  Aplica a prestaciones registradas en contextos de hospitalización. Considera conteo de días desde la fecha de ingreso hasta la fecha de alta.
- Definición Operacional
  Para los CPMS listados, el aplicativo controla que la cantidad registrada no exceda el tope máximo permitido, el cual se determina en función de los días de hospitalización reportados en el FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro del CPMS '99295' con 2 ejecutados con 3 días de hospitalización→ Registro exitoso.
  - No válido: Registro del CPMS '99206' con 10 ejecutados con 2 días de hospitalización→ No permite el registro

5.27 RC_74 Sustitución controlada de dispositivos médicos (marcapasos) por periodicidad

- Denominación
  Sustitución controlada de dispositivos médicos (marcapasos) por periodicidad.
- Objetivo

Garantizar el control en la sustitución de dispositivos médicos (marcapasos), estableciendo límites por periodicidad (anual, quinquenal y de por vida).

- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones recuperativas.
- Definición Operacional
  En el registro de prestaciones relacionadas con dispositivos médicos (como marcapasos), el aplicativo establece controles de sustitución mediante la aplicación de topes máximos que restringen su registro a un dispositivo por FUA ambulatorio, un dispositivo por FUA hospitalización, un dispositivo por asegurado por año, un dispositivo por asegurado por quinquenio y un número máximo vitalicio por asegurado.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Asegurado con 1 marcapaso en los últimos 5 años; FUA actual con CIE-10 T82: permitir hasta 2 en quinquenio → Registro exitoso
  - No válido: Asegurado con más de 5 marcapasos históricos equivalentes → No permite el registro.

5.28 RC_75 Coherencia clínica en el uso de dispositivos para marcapasos

- Denominación
  Coherencia clínica en el uso de dispositivos para marcapasos.
- Objetivo
  Restringir el uso de insumos destinados a la colocación de marcapasos a diagnósticos específicos.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones recuperativas.
- Definición Operacional
  Para cada código SISMED listado, se exige que la FUA tenga registrado al menos un diagnóstico CIE-10 dentro del conjunto permitido.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro de 25197 con CIE-10 I44→ Registro exitoso.
  - No válido: Registro de 23836 sin CIE-10 de la lista→ No permite el registro.
  -

5.29 RC_76 Restricción de procedimientos por diagnostico especifico

- Denominación
  Restricción de procedimientos por diagnostico especifico.
- Objetivo
  Restringir el uso de procedimientos de colocación de marcapasos a diagnósticos específicos.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones recuperativas.
- Definición Operacional

Para cada CPMS listado, se exige que el FUA tenga registrado al menos un diagnóstico CIE-10 dentro del conjunto permitido.

- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro de 33200 con CIE-10 I44→ Registro exitoso.
  - No válido: Registro de 33210 sin CIE-10 de la lista→ No permite el registro.

5.30 RC_77 Compatibilidad de códigos prestacionales

- Denominación
  Compatibilidad de códigos prestacionales.
- Objetivo
  Asegurar la correcta asociación entre códigos prestacionales conforme a los criterios establecidos por grupo etario y condición de salud.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  Para cada código prestacional principal, únicamente se habilitan los códigos preventivos previamente definidos. En caso de intentarse el registro de un código no autorizado para dicha prestación principal, el sistema bloqueará automáticamente su ingreso.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: 001 con registro de 016 y 007→ Registro exitoso.
  - No válido: 009 con 022 y 023→ No permite el registro.

5.31 RC_79 Consistencia entre código prestacional y profesional responsable

- Denominación
  Consistencia entre código prestacional y profesional responsable.
- Objetivo
  Garantizar que cada código prestacional sea registrado por el profesional de salud autorizado en los niveles II y III de atención.
- Alcance
  Aplica a prestaciones recuperativas especificas (056, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067 y 068).
- Definición Operacional
  Cada código prestacional cuenta con perfiles profesionales predeterminados. Si el registro no es efectuado por un profesional habilitado, la prestación será observada.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Código 061 registrado por Obstetra → Registro exitoso.
  - No válido: Código 068 registrado por Odontólogo→ No permite el registro.

5.32 RC_81 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades I

- Denominación
  Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades I.
- Objetivo
  Asegurar que una misma prestación no sea registrada de forma duplicada o desagregada en más de un código prestacional
- Alcance
  Aplica a prestaciones recuperativas especificas (056, 071, 062 y 063).
- Definición Operacional
  Se establece que, para cada intento de registro de un Formato Único de Atención (FUA), el aplicativo debe comparar los datos consignados con los de registros previamente ingresados. Si un nuevo registro (FUA 2) coincide con un registro existente (FUA 1) en fecha, hora y profesional responsable de la atención, y corresponde a los códigos prestacionales definidos como relacionados, dicho registro será clasificado como duplicado o desagregado indebido.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Se intenta registrar un FUA (2) con código 056 para el mismo afiliado, con diferente fecha, hora y profesional que un FUA (1) con código 056 → Registro exitoso.
  - No válido: Se intenta registrar un FUA (2) con código 062 para el mismo afiliado, con misma fecha, hora y profesional que un FUA (1) con código 062 → No permite el registro.

5.33 RC_83 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades II.

- Denominación
  Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades II.
- Objetivo
  Asegurar que una misma prestación no sea registrada de forma duplicada o desagregada en más de un código prestacional.
- Alcance
  Aplica a todas las prestaciones preventivas, recuperativas y de rehabilitación.
- Definición Operacional
  Se configura un duplicado cuando un segundo registro de Formato Único de Atención (FUA 2) se intenta ingresar con el mismo código prestacional que un registro previo (FUA 1) y, para el mismo afiliado, coinciden simultáneamente la fecha de atención, la hora de atención y la numeración del FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: FUA1 y FUA2 con mismo código 056, misma fecha/hora y mismo Lote+NumRegAte, para el mismo afiliado → No permite el registro.
  - Válido: FUA1 y FUA2 con distintos códigos prestacionales, diferente fecha y numero de FUA en un mismo afiliado → Registro exitoso.

5.34 RC_86 Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades III

- Denominación
  Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades III.
- Objetivo
  Asegurar que una misma prestación no sea registrada de forma duplicada o desagregada en más de un código prestacional.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  Se considera duplicado un Formato Único de Atención (FUA) cuando, respecto de un registro previo, coincide simultáneamente en los siguientes cinco criterios: código RENIPRESS del establecimiento de salud, número de contrato y documento de identidad del asegurado, fecha de atención, código de servicio y número de DNI del responsable de atención.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: FUA anterior y FUA posterior que no coinciden en los 5 criterios establecidos en la regla → Registro exitoso
  - No válido: FUA anterior y FUA posterior con mismo RENIPRESS, mismo contrato + DNI asegurado, misma fecha, mismo código de servicio y mismo DNI de responsable → No permite el registro.

5.35 RC_87 Restricción del registro de prestaciones según tipo de atención

- Denominación
  Restricción del registro de prestaciones según tipo de atención.
- Objetivo
  Asegurar que el registro de prestaciones de Telemedicina se ajuste al tipo de atención permitido.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  La sección “Atención” debe consignarse de acuerdo con el código prestacional registrado, correspondiendo únicamente a las categorías Ambulatoria, Referencia o Emergencia.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Código 300 (Telemedicina) usuario selecciona “Ambulatoria” → No permite el registro.

- Válido: Código 300 (Telemedicina) usuario deja en blanco la sección “atención” → Registro exitoso.

5.36 RC_88 Consistencia entre los diagnósticos y procedimientos según curso de vida

- Denominación
  Consistencia entre los diagnósticos y procedimientos según curso de vida.
- Objetivo
  Garantizar la coherencia entre diagnósticos, procedimientos y código prestacional según curso de vida.
- Alcance
  Aplicable a las prestaciones preventivas registradas en las IPRESS de primer nivel de atención.
- Definición Operacional
  Toda prestación preventiva registrada debe consignar obligatoriamente al menos un procedimiento (CPMS), garantizando la correspondencia entre el diagnóstico CIE-10, el código prestacional y el procedimiento asociado.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Registro del CIE 10 Z13.3 en el código 301 con el CPMS 96150.01 → Registro exitoso.
  - No válido: Registro del CIE 10 Z00.1 en el código 306 sin ningún CPMS asociado → No permite el registro.

5.37 RC_89 Registro condicionado de procedimientos a diagnósticos según curso de vida

- Denominación
  Registro condicionado de procedimientos a diagnósticos según curso de vida.
- Objetivo
  Habilitar y establecer los topes en los procedimientos realizados por los profesionales de salud no médicos (odontólogo, obstetra, enfermera, trabajadora social, psicólogo, nutricionista, técnico en enfermería y auxiliar de enfermería.) En el nivel I de atención relacionado al CIE 10 utilizado en la atención.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  Todo procedimiento (CPMS) registrado debe estar habilitado para el diagnóstico CIE-10 consignado y su ejecución debe mantenerse dentro de los topes mínimos y máximos predefinidos.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: COD. PREST. 301 + CIE-10 Z002 + CPMS 99381.01 con IND=1 y EJE=1 → Registro exitoso.

- No válido: COD. PREST. 301 + CIE-10 Z001 con un CPMS odontológico con IND=5 y EJE=5 → No permite el registro.

5.38 RC_90 Control de atenciones diarias en consulta externa brindado por personal de salud

- Denominación
  Control de atenciones diarias en consulta externa brindado por personal de salud
- Objetivo
  Establecer topes de atenciones diarias en consulta externa (modalidad intramural o extramural) por personal de salud, para garantizar el tiempo necesario por asegurado y fortalecer la calidad de la atención brindada.
  Alcance
  Aplica al personal de salud que brinda atención en consulta externa en las IPRESS del I, II y III nivel de atención.
- Definición Operacional
  Es el control del límite máximo de atenciones diarias en consulta externa por profesional de salud, según el nivel de atención de la IPRESS (I, II y III). El tope incluye todas las prestaciones registradas en el FUA, tanto intramural como extramural, asegurando que cada asegurado reciba el tiempo adecuado de atención y contribuyendo a la calidad y eficiencia del servicio.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: COD. PREST. 056 →tipo de personal Médico 1 → IPRES de III nivel → 30 atenciones (FUA) por día → Registro exitoso.
  - No válido: COD. PREST. 056 tipo de personal odontólogo 1 → IPRES de II nivel → 41 atenciones (FUA) por día → El FUA 41 es observado por la regla.

5.39 RC_91 Consistencia de diagnósticos por código prestacional

- Denominación
  Consistencia de diagnósticos por código prestacional
- Objetivo
  Controlar que los diagnósticos registrados sean consistentes y correspondan correctamente a los códigos de servicio en atenciones ambulatorias y de internamiento, asegurando la coherencia y calidad del registro de las prestaciones de salud.

  Alcance
  Aplica a las atenciones con códigos de servicio 056, 065, 066, 067 y 068 que cuentan con un único diagnóstico registrado, garantizando la consistencia entre la prestación brindada y el diagnóstico asociado.

- Definición Operacional

Controla que las atenciones con códigos de servicio 056, 065, 066, 067 y 068 cuenten con diagnósticos válidos, evitando que se registre un único diagnóstico y asegurando que cada prestación esté debidamente sustentada.

Ejemplos Prácticos

- Válido: COD.PREST. 067→ Diagnósticos CIE.10: Dx.1 (Q211), Dx.2 (Q250), Dx3(R520), Dx.4(I509) → Registro exitoso.
- No válido: COD. PREST. 068→ Diagnósticos CIE.10: Dx1 (D509) → se observa por la regla.

5.40 RC_92 Consistencia de registro de códigos prestacionales por nivel de atención

- Denominación
  Consistencia de registro de códigos prestacionales por nivel de atención.
- Objetivo
  Identificar el registro inadecuado de códigos prestacionales según nivel de atención.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  El registro de códigos prestacionales queda condicionado al nivel de atención autorizado. Cualquier intento de registro en un nivel distinto se considera improcedente y debe ser rechazado, garantizando la correspondencia entre la prestación registrada y el ámbito de atención que le corresponde.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Prestación 068 registrada en un establecimiento de I nivel de atención → No permite el registro.
  - Válido: Prestación 067 registrada en un establecimiento de II-2 → Registro exitoso

5.41 RC_94 Dispositivos médicos asociados a medicamentos

- Denominación
  Dispositivos médicos asociados a medicamentos.
- Objetivo
  Asegurar que el uso de determinados insumos médicos esté asociado únicamente a los medicamentos específicos establecidos.
- Alcance
  Aplica al registro de dispositivos médicos SISMED vinculados a nutrición parenteral, condicionando su ingreso a que en el FUA se registre al menos uno de los medicamentos SISMED permitidos para cada dispositivo.
- Definición Operacional
  Se establece control de consistencia entre dispositivo médico y medicamento cuando se intente registrar cualquiera de los dispositivos incluidos en la regla, el sistema no permite

el ingreso del dispositivo si no se consigna por lo menos uno de los medicamentos habilitados en la lista asociada a dicho dispositivo.

- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Registra dispositivo 39728 sin ningún medicamento de su lista (ej. 52910/52802/…/00633).
  - Valido: Registra dispositivo 54854 y en el mismo FUA registra al menos un medicamento permitido (ej. 55051)

5.42 RC_95 Coherencia clínica en el uso de surfactante pulmonar en el recién nacido

- Denominación
  Coherencia clínica en el uso de surfactante pulmonar en el recién nacido
- Objetivo
  Restringir el uso de surfactante pulmonar al diagnóstico de Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido, evitando su uso en condiciones no justificadas clínicamente y reduciendo el riesgo de sobreuso o inconsistencia prestacional.
- Alcance
  Aplica a todos los registros financiados por el SIS en los cuales se consigne alguno de los códigos SISMED correspondientes a surfactante pulmonar en IPRESS con atención neonatal.

  Códigos SISMED incluidos

  21864 – Surfactante pulmonar de origen natural, 8 ml, 25 mg/ml
  24719 – Surfactante pulmonar de origen natural, 3 ml, 80 mg/ml
  21837 – Surfactante pulmonar de origen natural, 8 ml, 30 mg/ml
  24064 – Surfactante pulmonar de origen natural, 1.5 ml, 120 mg/1.5 ml

- Definición Operacional
  Se establece un control de consistencia entre el registro del surfactante pulmonar y el diagnóstico CIE-10 consignado en el FUA, requiriendo obligatoriamente el diagnóstico P22.0.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: Registra el SISMED de surfactante pulmonar sin diagnóstico P22.0
    Valido: Registra el SISMED de surfactante pulmonar y diagnóstico P22.0 (RN con diagnóstico P22.0 y registro SISMED 21864).

5.43 RC_96 Consistencia de asociación obligatoria a CPMS base

- Denominación
  Consistencia de asociación obligatoria a CPMS base
- Objetivo
  Garantizar que los CPMS complementarios solo se registren cuando exista un CPMS base asociado, asegurando integridad del registro y control financiero.
- Alcance

Se aplica al registro de CPMS complementarios cuando se haya consignado previamente un CPMS base, el cual condiciona su registro en el FUA, en establecimientos de nivel II y III.

- Definición Operacional

  Con el nivel de información actualmente disponible en los registros de atención (FUA), limitado a códigos CPMS y su respectiva cantidad, el sistema no cuenta con variables estructuradas como pieza id, dimensiones de la muestra, número de bloques o láminas, que permitan identificar de manera fehaciente la existencia y procesamiento de piezas de anatomía patológica.
  Asimismo, el procedimiento BASE constituye el eje operativo y de control del proceso, en tanto asegura: el ingreso y la trazabilidad de la muestra, su adecuado procesamiento histológico, y la emisión del informe macro y microscópico correspondiente.
  En ausencia de dicho procedimiento BASE, cualquier prestación adicional asociada queda desvinculada del flujo operativo, generando un escenario de riesgo caracterizado por posibles omisiones en el registro, duplicidades, inconsistencias en la codificación y, principalmente, pérdida de trazabilidad del proceso asistencial.

- Ejemplos Prácticos

  - No válido: Registra CPMS 88314.01 sin ningún CPMS de BASE (88300,88301, 88304.etc.) → No permite el registro.
  - Valido: Registra CPMS 88318.01 (BASE) y registra su CPMS 88314.01, 88313, etc. (COMPLEMENTARIO) → Registro exitoso.

5.44 RC_97 Insumos con pertinencia de uso para los Procedimientos de Alto Costo que cobertura el FISSAL

- Denominación
  Insumos con pertinencia de uso para los Procedimientos de Alto Costo que cobertura el FISSAL
- Objetivo
  Restringir el registro de insumos para los Procedimientos de Alto Costo a diagnósticos e IPRESS específicos.
- Alcance
  Aplica a todas las IPRESS autorizadas por el FISSAL.
- Definición Operacional
  Cuando el insumo corresponda a un procedimiento de Alto Costo, el aplicativo exigirá de forma obligatoria que la prestación sea registrada únicamente por las IPRESS autorizadas y bajo el código CIE-10 específico correspondiente.

  Ejemplos Prácticos

- Valido: El aplicativo permitirá un registro exitoso cuando se ingrese el código SISMED 51840 (Set para cirugía laparoscópica) asociado al código CIE-10 Z52.4 (Donante de riñón), siempre que la atención sea reportada por una IPRESS autorizada como donador-trasplantador de riñón → Registro exitoso.

- No válido: El aplicativo rechazará el registro del código SISMED 51840 (Set para cirugía laparoscópica) si se asocia a un diagnóstico CIE-10 distinto a Z52.4 (Donante de riñón), o si la atención es reportada por una IPRESS que no cuenta con la autorización de donador-trasplantador de riñón. → NO permite el registro.

5.45 RC_98 Registro obligatorio de diagnósticos en la atención del parto

- Denominación
  Registro obligatorio de diagnósticos en la atención del parto
- Objetivo
  Validar que las atenciones de parto consignen como diagnóstico secundario un código de la categoría Z37 del CIE-10, correspondiente al resultado del parto, a fin de garantizar la consistencia e integridad de la información clínica registrada en el FUA.
- Alcance
  Aplica a todas las IPRESS a nivel nacional que registren atenciones en el FUA bajo los códigos prestacionales correspondientes a parto (ej. 054, 065 u otros aplicables).
- Definición Operacional
  Cuando se registre una atención que comprenda parto, el aplicativo verificará obligatoriamente que se haya registrado un diagnóstico secundario perteneciente a la categoría Z37 (Resultado del parto). Si el FUA no incluye este diagnóstico secundario, o si el código de la categoría Z37. ingresado no es coherente con el diagnóstico principal del tipo de nacimiento, el sistema bloqueará el guardado del registro y mostrará un mensaje de inconsistencia
- Ejemplos Prácticos

  - Valido: FUA con cód. 065 (parto por cesárea) con diagnóstico principal O842 (Parto múltiple, todos por cesárea) y diagnóstico secundario Z372 (Gemelos, ambos nacidos vivos) → Registro exitoso.
  - No válido: FUA con cód. 054 (parto vaginal) con diagnóstico principal O800 (Parto único espontáneo, presentación cefálica) y sin diagnóstico secundario de la categoría Z37 (Resultado del parto) → No permite el registro.

6 REGLAS DE VALIDACIÓN

6.1 RV_26 Restricción de medicamentos e insumos evaluados según ETS.

- Denominación
  Restricción de medicamentos e insumos evaluados según ETS.
- Objetivo

Identifica medicamentos e insumos evaluados por ETS.

- Alcance

  Aplica a todos los FUAs que registren medicamentos o insumos SISMED sujetos a ETS, validando por ítem si cuentan con aprobación y si cumplen criterios (diagnóstico no presuntivo, edad, sexo e IPRESS autorizada); de no cumplirse, se genera observación parcial sin invalidar el FUA.

- Definición Operacional

  Cada ítem SISMED consignado en el FUA se contrasta con los catálogos autorizados por la ETS. Cuando el ítem no cuente con aprobación, se genera observación parcial. En los casos de ítems con aprobación condicionada, se exige la verificación de diagnóstico, edad, sexo e IPRESS autorizada; si uno o más de estos criterios no se cumplen, se genera observación parcial, manteniéndose la validez del resto del FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - No válido: 26-2: Nivolumab sin diagnóstico C43 o en IPRESS no autorizada → Observa el registro.
  - Válido: Registro de Inmunoglobulina Humana Normal con el CIE 10 Hipogammaglobulinemia hereditaria (D800), en la institución 0000006216 → Registro exitoso

6.2 RV_28 Restricción de productos de origen biológico o de alto costo

- Denominación

  Restricción de productos de origen biológico o de alto costo no evaluados por ETS o con autorización restringida por PNUME.
- Objetivo

  Identificar medicamentos de origen biológico o de alto costo que no cuentan con evaluación de ETS, medicamentos con PNUME restringido (nivel de atención y diagnóstico).
- Alcance

  Aplica a FUAs que registren productos biológicos priorizados con autorización restringida por PNUME.
- Definición Operacional

  Se establece que los FUAs que consignen códigos SISMED de productos biológicos priorizados con ETS o autorización restringida por PNUME deberán registrar al menos un diagnóstico CIE-10 específico en condición de no presuntivo y encontrarse vinculados a una IPRESS autorizada; de no cumplirse estas condiciones, se generará observación parcial, sin invalidar la totalidad del FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Trastuzumab (SISMED 17689) con registro de CIE 10 C50.0, en la IPRESS 00001231 → Registro exitoso.

- No válido: Busulfano (SISMED 01387, 25050): registrado en IPRESS que no es Nivel III y que no cuenten con prestaciones oncológicas y oncohematología → Observa el registro.

6.3 RV_29 Restricción de registros en exceso de CPMS de tomografía

- Denominación
  Restricción de registros en exceso de CPMS de tomografía.
- Objetivo
  Restringir el exceso de registro de CPMS de tomografía en el II y III nivel de atención.
- Alcance
  Aplica a los códigos prestacionales preventivos especificados en la ficha técnica de la regla.
- Definición Operacional
  El registro de procedimientos tomográficos en el FUA se restringe a los topes máximos definidos por combinación código prestacional–nivel de atención (II o III. El exceso del tope genera observación parcial con el código correspondiente (29-01 al 29-05), sin invalidar el resto del FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Código prestacional 051 en nivel II con 1 CPMS de la Lista → Registro exitoso.
  - No válido: Código prestacional 065 en nivel III con 5 CPMS de la Lista → Observa el registro.

6.4 RV_30 Restricción de registro medicamentos en hospitalización

- Denominación
  Restricción de registro medicamentos en hospitalización.
- Objetivo
  Establecer topes de registro de medicamentos (inyectables y tabletas) a hospitalizados según nivel de atención.
- Alcance
  Aplica a códigos prestacionales que cuenta con estancia hospitalaria.
- Definición Operacional
  Se establece control sobre la cantidad de unidades dispensadas por medicamento, de acuerdo con la forma terapéutica (Inyectables y tabletas) y el nivel de atención de la IPRESS. Cuando el registro excede el tope máximo permitido, se genera observación parcial, manteniéndose válidos los demás consumos consignados en el FUA.

- Ejemplos Prácticos
  - Válido: Si la IPRESS nivel II en una FUA de código prestacional 065 registra 199 inyectables → Registro exitoso.
  - No válido: Si la IPRESS nivel III en un FUA de código prestacional 051 registra 500 inyectables → Observa el registro.

6.5 RV_31 Diagnóstico de sepsis neonatal sustentado en criterios clínicos y de laboratorio.

- Denominación
  Diagnóstico de sepsis neonatal sustentado en criterios clínicos y de laboratorio.
- Objetivo
  Mejorar la precisión diagnóstica y reducir el sobrediagnóstico de sepsis neonatal, disminuyendo el uso innecesario de antibióticos y estancias prolongadas.
- Alcance
  Aplica a IPRESS categoría III, para FUA con código prestacional 0068 y diagnóstico CIE-10: P36, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P368, P369.
- Definición Operacional
  Se establece control del sustento del diagnóstico de sepsis neonatal en el FUA: cuando en un FUA con código prestacional 068 (IPRESS categoría III) se registre P36 o alguna de sus subcategorías (P360, P361, P362, P363, P364, P365, P368, P369), debe consignarse como mínimo uno de los siguientes estudios de laboratorio: hemocultivo (CPMS 87040.01 o 87040.02), hemograma (CPMS 85022, 85023 o 85024) o proteína C reactiva (CPMS 86140); si no se registra al menos uno, se genera observación automática y se observarán todos los insumos, medicamentos y procedimientos relacionados con el diagnóstico de sepsis neonatal, manteniéndose válido el resto del FUA.
- Ejemplos Prácticos
  - Válido: 068 + P36 + registra hemograma (CPMS 85022) → Registro exitoso.
  - No válido: 068 + P369 + no registra hemocultivo/hemograma/PCR → Observa el registro.

7 ACTUALIZACIONES Y NUEVAS REGLAS

7.1 ACTUALIZACION DE REGLAS SEGUN INFORME N.º 000012-2026-SIS/GREP-VCD (03/06/2026)

7.1.1. Actualización de la RR_02[1]

Restricción del registro de insumos no asociados a la atención individual de salud

Modificación:

- Se elimina la restricción de los insumos: SISMED 51840 (SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 10 PIEZAS, y el SISMED 41694 (LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm , 2.3 mm).

[1] MEMORANDO N°000684-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000964-2026-SIS/GREP.

7.1.2. Actualización de la RC_01[2]

Consistencia de registro de prestaciones por edad, sexo y condiciones del asegurado.

Modificación:

- Para el código prestacional 050 (Atención del recién nacido), se amplía la edad máxima de atención hasta los 28 días de nacido.

7.1.3. Actualización de la RC_06[3]

Límites de registro de medicamentos por unidad de medida

Modificación:

- Para el Valproato Sódico 500mg (Código SISMED 40803), se aumenta el tope máximo a 370 unidades. Esto aplica solo en el III nivel de atención para pacientes no hospitalizados (servicios 056 y 300), prescrito por un médico especialista en Neurología o Psiquiatría con RNE.
- Para la Pancreatina 300mg (Código SISMED 05270), ahora se permite hasta 3,300 unidades para pacientes ambulatorios con Fibrosis Quística (CIE-10: E840 al E849) con diagnóstico definitivo o repetitivo. Aplica solo para atenciones de médicos especialistas con RNE en el III nivel.
- Se incluyen los códigos prestacionales 301-306 en el cuadro de topes máximos de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC). Esto regula los diagnósticos de salud mental y las tabletas prescritas por profesional médico.
- Se eliminan las formas farmacéuticas TAB LIB PRO, TAB RAN, TAB SL y TAB VAG de la ficha, al no encontrarse en los catálogos de la DIGEMID ni en el de la GNF.

7.1.4. Actualización de la RC_14[4]

Obligatoriedad de registro de actividades preventivas y clínicas por código prestacional

- Los códigos CIE-10 referidos al producto del parto (Z370 al Z379) han sido eliminados de la lista de diagnósticos permitidos para el grupo de diagnósticos del recién nacido.

7.1.5. Actualización de la RC_20[5]

Consistencia de registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención.

Modificación:

---

[2] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP.
[3] MEMORANDO N° 000864-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000783-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000758-2026-SIS/GREP
[4] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP
[5] MEMORANDO N° 000933-2026-SIS/GREP

- El procedimiento de Psicoeducación al usuario de salud (99207.04) ya no es exclusivo para médicos y psicólogos. Se retiró esa restricción de uso.

7.1.6. Actualización de la RC_32[6]

Consistencia clínica en procedimientos mutuamente excluyentes

Modificación:

- Se incorporan los CPMS de Evaluación médica (99214) y Evaluación clínica (99207.03) al grupo de procedimientos de Consultas Externas y Evaluaciones Médicas Especializadas. Su aplicación se configura como excluyente entre sí, permitiendo el registro de solo uno de ellos.

7.1.7. Actualización de la RC_39[7]

Límites de registro por procedimiento, vinculados a códigos prestacionales.

Modificación:

- Para los CPMS 99262 Día paciente en hospitalización general (incluye admisión y alta) y 99263 Día paciente en hospitalización de cuidados intermedios (incluye admisión y alta), se actualiza el tope máximo a uno (1), aplicando esta restricción tanto para el valor indicado como para el ejecutado.
- Para el procedimiento Tamizaje neonatal (Hipotiroidismo congénito, Hiperplasia suprarrenal, Fenilcetonuria, Fibrosis quística) con código CPMS 80099, se amplía el tope máximo a dos (2) tanto en el valor indicado como en el ejecutado. Esta actualización aplica para los códigos prestacionales 051, 052 y 068.

7.1.8. Actualización de la RC_47[8]

Consistencia multinivel y multivariables en procedimientos

Modificación:

- Se actualizan los rangos de edad para los procedimientos de atención del recién nacido CPMS 99460 y 99436. Asimismo, se incorporan los CPMS 99431 (Anamnesis y el examen físico del recién nacido) y 99433 (Evaluación y manejo diario de un recién nacido) para uso exclusivo del profesional médico en todos los niveles de atención.

  Finalmente, se precisa que el CPMS 99296 (Evaluación y manejo subsecuente por día de un paciente críticamente enfermo de 28 o menos días de edad) aplica únicamente para pacientes menores de 28 días.

[6] MEMORANDO N° 000862-2026-SIS/GREP
[7] MEMORANDO N° 000861-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000899-2026-SIS/GREP
[8] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP

7.1.9. Actualización de la RC_53[9]

Criterios de registro de los diagnósticos cie 10 según edad y condición materna.

Modificación:

- Se agregan los códigos CIE-10 de producto del parto (Z37.0 al Z37.9), los cuales serán de uso exclusivo para pacientes de sexo femenino en condición de gestante o puérpera.

7.1.10. Actualización de la RC_88[10]

Consistencia entre los diagnósticos y procedimientos según curso de vida.

- Los códigos CIE-10 referidos al producto del parto (Z370 al Z379) han sido eliminados de la lista de diagnósticos permitidos para el grupo de diagnósticos del recién nacido.
- Se incorporan los procedimientos relacionados a la Atención del recién nacido en alojamiento conjunto (CPMS 99431, 99433 y 99460) para su registro obligatorio de alguno de los procedimientos en la atención del recién nacido. Asimismo, se incluye el procedimiento Consejería en salud ocular (CPMS 99401.16) como una condición obligatoria cuando se registre el código CIE-10 Z01.0 (Examen de ojos y de la visión).

7.1.11. Actualización de la RC_89[11]

Registro condicionado de procedimientos a diagnósticos según curso de vida.

Modificación:

- Se incorporan 22 procedimientos médicos con sus respectivos topes mínimos y máximos para los campos indicado y ejecutado, asociados a diversos grupos de diagnósticos. Asimismo, se adiciona el diagnóstico con código CIE-10 Z12.9 (Examen de pesquisa especial para tumor de sitio no especificado).
- Los códigos CIE-10 referidos al producto del parto (Z370 al Z379) han sido eliminados de la lista de diagnósticos permitidos para el grupo de diagnósticos del recién nacido.

[9] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP
[10] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000865-2026-SIS/GREP
[11] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000865-2026-SIS/GREP

7.1.12. Actualización de la RC_94[12]

Dispositivos médicos asociados a medicamentos

Modificación:

- Se elimina el insumo con código SISMED 16433 (Filtro para soluciones intravenosas para nutrición parenteral). Con este ajuste, el sistema ya no exigirá de forma obligatoria el registro del medicamento de nutrición parenteral al usar este código.

7.1.13. Actualización de la RV_26[13]

Restricción de medicamentos e insumos evaluados según ETS

Modificación:

- Para la IPRESS Hospital Nacional Arzobispo Loayza (RENIPRESS 00006207), se incorpora la autorización de registro para los códigos SISMED de Inmunoglobulina Humana Normal, Bosentán e Imiglucerasa, vinculados a determinados diagnósticos.

7.1.14. Actualización de la RV_29[14]

Modificación:

- Se incorporan precisiones en la ficha técnica respecto a los criterios de validación, topes máximos y excepciones, a fin de garantizar la correcta aplicación de las reglas de validación RV29 y RV29-A.

7.2 CREACION DE REGLAS SEGÚN INFORME N.º 000012-2026-SIS/GREP-VCD (03/06/2026)

7.2.1. Creación de la RC_97[15]

Insumos con pertinencia de uso para los Procedimientos de Alto Costo que cobertura el FISSAL.

Objetivo

Restringir el registro de insumos para los Procedimientos de Alto Costo a diagnósticos e IPRESS específicos.

[12] MEMORANDO N° 000863-2026-SIS/GREP
[13] MEMORANDO N° 000719-2026-SIS/GREP
[14] MEMORANDO N° 000682-2026-SIS/GREP, MEMORANDO N° 000900-2026-SIS/GREP
[15] MEMORANDO N° 000684-2026-SIS/GREP.

7.2.2. Creación de la RC_98[16]

Registro obligatorio de diagnósticos en la atención del parto

Objetivo

Validar que las atenciones de parto consignen como diagnóstico secundario un código de la categoría Z37 del CIE-10, correspondiente al resultado del parto, a fin de garantizar la consistencia e integridad de la información clínica registrada en el FUA.

[16] MEMORANDO N° 000866-2026-SIS/GREP, Correo electrónico N°0170-2026-VECD-GREP-SIS, Correo electrónico N°0192 -2026-VECD-GREP-SIS